

就労継続支援 B 型 新モデル構築のための 学術データ・研究・実態データ集

(GH 連携型 × ひきこもり・在宅就労型 / 2026 年 8 月時点)

0. この資料の位置づけと使い方

既に手元にある 3 資料 (①方針資料、②新規開設調査、③制度・報酬・運営基準) は「WHY / RULE / HOW」を押さえるための資料でした。

本資料はそこに欠けていた **4 本目** = 「**EVIDENCE** (根拠となる数字と研究)」です。

用途は 3 つに絞ってください。

用途	使う場面	本資料の該当章
代表への提案の説得力を作る	「なぜこのモデルか」「なぜこの順序か」	2 章・3 章・4 章
行政 (指定権者) との事前協議	「在宅利用をどう成立させるか」 「地域ニーズはあるか」	1 章・5 章
収支シミュレーションの前提を作る	工賃・稼働・報酬区分の前提数値	1 章・2 章

重要な注意 (先に読んでください)

本資料の数値は公開情報の調査に基づいて整理しています。

ただし 代表提出・行政提出・収支計算に使う数値は、必ず本資料末尾 (6 章) の一次資料 URL で原典確認してください。

特に「①令和 8 年度報酬改定」「②工賃実績」「③在宅支援要件」の 3 点は、数字が変わると事業計画の結論そのものが変わる項目です。

1. 【最重要】前提を変える制度・報酬データ

ここは「知識」ではなく 収支の前提が変わる数字 なので最優先です。

1-1. 令和 8 年度 (2026 年度) 報酬改定 — 新規指定事業所への基本報酬引き下げ

項目	内容
就労継続支援 B 型 (新規指定)	所定単位数の 984/1000 (約 1.6%減)
共同生活援助 (包括型・日中支援型 / 新規指定)	所定単位数の 972/1000 (約 2.8%減)
適用開始	令和 8 年 6 月～

項目	内容
対象	施行日以降に新規指定を受ける事業所（既存事業所は従来どおり）
除外特例	重度障害者の受入れ／サービスが不足している地域での開設 は対象外とされる

この数字が意味すること（事業判断への直結点）

1. 「今から新規で就 B を作る」こと自体が、既存拠点より不利な単価から始まることを意味します。収支シミュレーションは **984/1000 の保守ケース** と **既存指定を活用できたケース** の 2 本立てで作るべきです。

2. **除外特例の 2 要件（重度受入れ／サービス不足地域）** に該当できるかどうか、モデル地域選定の新しい選定基準になります。

→ 「RASIEL/INNOVEL がある地域」だけでなく「B 型供給が不足している地域か」を必ず重ねて見る。

3. GH 側も 972/1000 のため、**今後の GH 新規開設にも同じ論点が乗ります**。
代表への説明では「就 B と GH の新規開設は、両方とも 2026 年 6 月から単価条件が変わった」とセットで説明した方が、意思決定の精度が上がります。

4. 行政事前協議の質問リストに以下を必ず追加：

- ・「当該市町村は“サービスが不足している地域”の特例に該当し得るか」
- ・「既存事業所への多機能型追加は、新規指定扱いとなるか」

出典：aimari-office / snabi-biz / hugmate / ATLIFE の改定解説（下記 6 章）※単位数・特例要件は必ず厚労省告示・通知の原典で確認してください。

1-2. 平均工賃月額と報酬区分

年度	全国平均工賃月額（B 型）
令和 5 年度（2023）	23,053 円
令和 6 年度（2024）	24,141 円（前年度 22,649 円との比較記載もあり、要原典確認）

- ・令和 6 年度改定で **平均工賃月額の算定方法が変更**（分母が「工賃支払対象者数」→「1 日あたり平均利用者数」）。

→ 古い年度の工賃数値と単純比較できません。既存 B 型の分析時に必ず注意してください。

- ・令和 8 年度改定で **平均工賃月額の区分基準が引き上げ**（3,000 円引き上げとの解説あり）。

→ 同じ工賃実績でも報酬区分が下がりうるため、既存拠点の区分シミュレーションを先に回す必要があります。

平均工賃月額の基本式

$$\text{年間工賃支払総額} \div (\text{年間延べ利用者数} \div \text{年間開所日数}) \div 12$$

事業判断への直結点

工賃は福利厚生ではなく翌年度の基本報酬を決める経営変数です。

法人内業務（BPO）を B 型へ発注するモデルは、

「安定した生産活動収入 → 工賃原資 → 報酬区分維持」という

報酬区分を守るための構造として説明できます。ここが代表提案での最大の武器になります。

1-3. 就労選択支援（令和 7 年 10 月～）

項目	内容
開始	令和 7 年 10 月 1 日
B 型	令和 7 年 10 月以降、新たに B 型利用を希望する者のうち現行の就労アセスメント対象者は原則として就労選択支援を利用
A 型・就労移行（標準利用期間超）	令和 9 年 4 月以降、原則利用
例外	50 歳以上／障害基礎年金 1 級受給者 等は必須ではなく希望に応じた利用

事業判断への直結点

- ・利用者導線は「ひきこもり→区分取得→B 型」ではなく「相談 → 障害福祉サービス対象確認 → 就労選択支援 → 支給決定 → B 型」。
- ・つまり モデル地域に就労選択支援事業所が存在するか／どこが担うか が、利用者獲得のボトルネックになり得ます。地域資源調査の必須項目に追加してください。
- ・逆に言えば、自法人で就労選択支援を持つことは強力な入口戦略になり得ます（要検討論点）。

1-4. 在宅利用（在宅支援）の要件 — ここが構想②の生命線

現行運用で求められている主な要件（自治体 Q&A・通知ベース）：

- ・事業所職員による訪問・通所・ICT 機器（電話/PC 等）の活用により、週 1 回以上の評価等を実施
- ・月の利用日数のうち原則 1 日は、訪問または通所により事業所内で訓練目標の達成度評価等を実施
- ・市町村が「在宅での支援効果がある」とあらかじめ判断することが必要
- ・運営規程への明記、記録、定期的な評価、対面が原則、緊急時対応の整備
- ・在宅支援は本来「重度で通所が困難な利用者等」を対象とする趣旨

さらに 令和 8 年 4 月 13 日付 事務連絡「就労移行支援事業、就労継続支援事業（A 型、B 型）における在宅支援の要件遵守の徹底について」により、

在宅支援の要件確認・適正化が改めて求められています（不適切ケースの是正）。

事業判断への直結点（ここは慎重に）

「全国の引きこもりの方に在宅で PC 仕事を渡せば B 型になる」は成立しません。

- ・在宅型モデルは「制度上できるか」ではなく「この市町村が個別に在宅利用を適当と判断するか」に依存します。
- ・したがって モデル地域決定 → 指定権者・市町村との事前協議 が、物件探しより前に来ます。

- ・ 2026 年に要件遵守の徹底通知が出ている以上、**在宅比率が高い設計は運営指導リスクが上がっている**という前提で、

「通所＋在宅の併用型」を基本設計にするのが安全です。

- ・ 週 1 回評価・月 1 回対面という要件は、**支援人員の工数を直接規定します。**

在宅利用者 n 人あたり何時間の職員工数が必要かを、収支シミュレーションに必ず織り込んでください。

2. 市場・供給側の実態データ（B 型の全国像）

指標	数値	備考
B 型事業所数	平成 27 年 9,698 か所 → 令和 4 年 15,748 か所（約 1.6 倍）	急増市場
事業所数（別ソース）	令和 6 年度報酬改定検証調査の母集団に 25,767 事業所 の記載	集計基準が異なるため要原典確認
利用者数	約 38 万人（2022 年度時点の推計）	
利用者の障害種別	知的 52% / 精神 37% / 身体 10% / 難病等 1%	大阪府 令和 5 年度実績資料
B 型からの一般就労移行率	約 1 割（13.2%との記載もあり、資料により幅）	出口設計の現実値
生産活動収支	一定の基準を満たしていない事業所が 50.7%（令和 5 年 3 月末時点）	経営改善が課題
収支差率	サービス活動収益対増減差額比率 7.8%、黒字事業所は 66%（≒約 34%が赤字）	福祉医療機構 2020 年度

このデータの読み方 ― 代表への説明で使える論点

1. **B 型は供給過剰気味の成熟市場**です。「拠点数を増やす」だけの戦略は、単価も工賃も下がる方向に働きます。

→ 資料①の結論（「増やすことではなく再現可能なモデルを 1 つ完成させること」）は、この市場データで裏づけられます。

2. **利用者の 37%が精神障害**。つまり、GH（RASIEL/INNOVEL）が精神障害者を主対象としているなら、

法人の既存アセットと市場の主要セグメントが一致しています。これは差別化ではなく「勝ち筋の土台」です。

3. **約 3 割～5 割の事業所が経営的に苦しい**。参入の是非ではなく、「なぜ苦しいのか＝仕事がない／工賃が出せない」という失敗要因が明確です。

→ **法人内業務を先に確保してから開設する**という今回のモデルは、この最大の失敗要因を構造的に回避します。

ここが代表提案の中核メッセージになります。

3. 対象者側の実態データ（ひきこもり・精神障害・GH 利用者）

3-1. ひきこもり（構想②の市場規模）

指標	数値	出典
全国推計（15～64 歳）	約 146 万人（15～64 歳人口の約 2% = 50 人に 1 人）	内閣府 令和 4 年度「こども・若者の意識と生活に関する調査」
「誰にも相談したくない」	15～39 歳 22.9% / 40～69 歳 18.1%	同上
相談したくない理由（15-39 歳最多）	「相談しても解決できないと思う」51.5%	同上
就労経験あり	40～64 歳で 90.3%、15～39 歳でも 6 割超	同上
ひきこもり地域支援センター	全都道府県・指定都市（67 自治体）に設置済、市町村へ拡充（R7 年度 47 自治体）	厚労省
ひきこもり支援ステーション事業	R7 年度 129 自治体	厚労省
ひきこもりサポート事業	R7 年度 164 自治体	厚労省

このデータの読み方 — ここが構想②の設計を決めます

1. 市場規模は十分にあります（50 人に 1 人）。人口 10 万人の市なら、単純計算で約 2,000 人規模。

→ モデル地域の潜在対象者数は「人口 × 2%」で粗く見積もれます。営業資料に使えます。

2. しかし「相談したくない」層が約 2 割、その最大理由が「相談しても解決しない」。

→ 通常の広報・営業では届きません。待ちの窓口を作っても人は来ない、というのがデータの結論です。

→ 家族経由・医療経由・行政経由の間接ルート的设计が必須。

3. 9 割が就労経験あり（40～64 歳）。

→ 「働けない人」ではなく「働いた経験があるが、今は職場に行けない人」。

これは在宅・低負荷・段階的な仕事設計と相性が良いことを意味します。

代表への説明でも「就労未経験者を育てる事業」ではなく「就労経験の再起動」と位置づけた方が正確です。

4. 支援ステーション事業・サポート事業の実施自治体数（129・164）は、

モデル地域選定の指標として使えます。実施自治体 = ひきこもり支援に予算と体制を持つ自治体 = 連携先が存在する。

3-2. 精神障害・医療のボリューム

指標	数値
精神障害者の概数	約 614.8 万人（令和 6 年版障害者白書）
精神疾患 総患者数	令和 2 年 約 614.8 万人 → 令和 5 年 約 603.0 万人
うち外来	令和 5 年 約 576.4 万人（入院 約 26.6 万人）
疾病別	気分障害 169.3 万人 / 神経症性・ストレス関連 123.7 万人 / 統合失調症圏 73.7 万人
障害児・者総数	1,164 万人（精神が 57%増で最多）

読み方：対象者の圧倒的多数は**外来通院者**です（入院は約 4%）。

→ 利用者獲得の主戦場は病院の病棟ではなく、**精神科クリニック・訪問看護・デイケア**。

営業先の優先順位づけに直結します。

3-3. GH 利用者の日中活動（構想①の初期利用者を推計する数字）

全国グループホーム実態調査（令和 3 年度・1,329 事業所／5,176 ホーム／入居者 27,527 人）より：

日中活動	人数	割合
一般就労	4,138 人	15.0%
就労継続 A/B 型・就労移行を利用	11,319 人	41.1%
（残余：生活介護・日中活動なし等）	—	約 44%

このデータの読み方 — 構想①の事業規模を即座に試算できます

- GH 入居者の **約 41%**が既に就労系サービスを利用中＝法人内 B 型に転換できる潜在層。
- 残る約 44%には **生活介護利用者**と「**日中活動なし**」層が含まれます。ここが新規開拓余地。
- **試算例：**自法人 GH 入居者が仮に 200 名なら、
- 既に就労系利用中：約 82 名（→ 法人内 B 型へ切替え可能性のある層）
- 日中活動なし等：数十名規模（→ 新規 B 型利用の候補）

→ **定員 20 名の B 型 1 拠点なら、GH 由来だけで初期利用者を埋められる可能性が高い**という説明ができます。

- **これが構想①（GH 連携型）を先に着手すべき最大の根拠**です。構想②は市場は大きいが立ち上がりが遅い。

※必ず自法人の実数（RASIEL・INNOVEL 入居者の日中活動先内訳）を取ってこの表と重ねてください。
これが「法人内業務棚卸し表」と並ぶ、最優先の内部データです。

4. 学術エビデンス（研究論文ベース）

ここは「代表・行政・職員に対して、支援モデルの妥当性を説明する根拠」です。

4-1. 就労支援の効果 — IPS（個別就労支援プログラム／援助付き雇用）

世界のメタアナリシス（PLOS ONE 2019, RCT 25 件）

アウトカム	効果
一般就労（competitive employment）の獲得	リスク比 1.63（95%CI 1.46–1.82）＝通常支援の約 1.6 倍
就労継続期間（job tenure）	d = 0.55
就労期間（job length）	d = 0.46
収入	d = 0.48
QOL	d = 0.30（有意でない）
全般的機能	d = 0.09（有意でない）
精神症状	d = 0.03（有意でない）

日本での知見

- 日本でも **3 件の RCT** が実施され、うち **2 件で IPS に準ずる個別型援助付き雇用の有意性**が示されている（NCNP）。
- IPS モデルの就労率は約 55%（従来支援の約 2.5 倍）との報告。
- 長期追跡のシステマティックレビューでは、IPS 利用者の **40～70%が研究期間中に少なくとも一度は就労を経験**。

この研究が示す実務上の含意 — モデル設計に直接効く 3 点

1. 「準備してから就労」ではなく「就労しながら支援」が有効（IPS の中核原則）。

→ 在宅 B 型モデルでも「訓練が済んでから仕事を渡す」設計にしない。

最初から実際の法人内業務を渡し、支援を併走させる方が、エビデンスに沿っています。

2. 就労支援と生活支援をセットで提供するのが IPS の原則。

→ **GH（住まい）＋就 B（働く場）**を同一法人で持つ今回の構想は、**IPS の構造そのものです**。

これは代表提案で強く使えるロジックです。「思いつき」ではなく「国際的に効果が実証された支援構造と同型」と説明できます。

3. ただし **QOL・症状・機能への効果は有意でない**（d=0.03～0.30）。

→ 「働けば症状が良くなる」とは言えません。職員研修・家族説明では過剰な期待を持たせないこと。

訴求すべきは「就労・収入・継続」であって「治療効果」ではありません。ここは誠実に線を引くべき点です。

4-2. 就労と精神健康 — 失業のインパクト（Paul & Moser 2009）

横断研究 237 件・縦断研究 87 件のメタアナリシス（Journal of Vocational Behavior）：

指標	数値
失業者 vs 就業者の心理的苦痛	d = 0.51
心理的問題を抱える割合	失業者 34% vs 就業者 16%
因果性	縦断研究・自然実験により、失業が苦痛を「引き起こす」ことを支持
失業者向け介入プログラムの効果	d = -0.35 (中程度の効果)

含意：4-1 で「就労は症状を改善しない」と書きましたが、

逆向き（働けない状態が続くこと自体が心理的苦痛を生む）には因果的証拠があります。

→ ひきこもり状態への早期の就労機会提供を正当化する、最も強いエビデンスがこれです。

→ 代表への説明ロジックは「働けば治る」ではなく「**働けない状態の長期化が有害である**」とすべきです。

4-3. ひきこもりの疫学と精神科的併存

知見	内容	出典
有病率メタ分析（19 研究）	全体 8.0%（95%CI 4.9–12.9%）。尺度により大差（HQ-25 使用時 21.7% vs 他 5.0%）	Zhang et al., Psychiatry Clin Neurosci 2025
生涯の精神疾患併存	ひきこもり経験者の 54.5% が気分・不安・衝動制御・物質関連障害の生涯罹患	Koyama et al. 2010（日本の地域住民調査）
具体的併存	社交不安 27%、回避性パーソナリティ 41%、うつ 32%	日米サンプル
治療の考え方	多次的な支援が必要、家族支援が非常に重要というのが広い合意	レビュー

含意 — これは職員研修と支援設計の根拠になります

1. ひきこもり = 怠けではなく、半数以上に精神疾患の併存がある。

→ 支援体制に**精神科・訪問看護との連携を最初から組み込む**必要があります。

（＝自法人の精神科領域の知見・週次レポート運用が活きる領域です）

2. **社交不安・回避性が中心的**（27%・41%）。

→ 「通所できない」の本質は移動困難ではなく**対人場面の回避**であることが多い。

→ 在宅就労の設計では、**対人接触の量を段階的に増やせる工程設計**が有効。

（例：①非同期のチャットのみ → ②音声のみ面談 → ③ビデオ面談 → ④職員訪問 → ⑤月 1 通所）

これは在宅支援要件（週 1 回評価・月 1 回対面）とも整合します。

3. うつ 32%を踏まえ、**作業量・納期のコントロール**は支援上必須。

→ 前章の「納期区分 C・D（月末まで／期限なし）の仕事から始める」という方針は、

臨床的にも妥当です。

4-4. 家族支援のエビデンス（CRAFT／ひきこもり家族介入）

- ・ ひきこもり当事者の家族向けに、**MHFA + CRAFT** を基にした **3 日間介入プログラム**のパイロット RCT が実施

（Frontiers in Psychiatry 2022／TAU 群 15 名 vs プログラム群 14 名）。

- ・ 結果：家族の関わり方の改善に一定の効果が見られる一方、家族の自信の向上には改善余地があり、プログラム改訂の必要性が指摘されている。
- ・ CRAFT 自体は、治療抵抗性の物質使用者を治療につなげる手法として有効性が確立（エンゲージメント率向上）。

含意 — 構想②の「入口」はここです

本人に直接アプローチできない以上、**家族が最初の接点**になります。

CRAFT の発想（家族の関わり方を変えることで本人の相談・受診・利用につなげる）を、

家族向け相談会・家族会連携という形で事業に組み込むのが、エビデンスに沿った入口戦略です。

→ 3-1 の「相談したくない 22.9%」問題への、唯一実証的な回答がこれです。

→ 営業先に **KHJ 全国ひきこもり家族会連合会の地域家族会** を必ず入れてください。

4-5. 在宅就労・テレワークの研究

資料	内容
障害者職業総合センター（NIVR）調査研究報告書 No.171（2023 年 3 月）	「テレワークに関する障害者のニーズ等実態調査」。テレワークで働く障害者・企業人事双方へのヒアリングにより課題と対処法を整理
厚生労働科学研究「就労系障害福祉サービス事業所におけるテレワークによる就労の推進のための研究」	知的障害・高次脳機能障害・てんかんを含む発達障害及び精神障害を対象に、テレワーク就労の支援実績・在宅職業訓練のノウハウを研究。今回の構想に最も近い研究
厚労省「障害者テレワーク事例集（都市部と地方をつなぐ）」	地方在住障害者×都市部企業のテレワーク雇用マッチング事例
NIVR 調査研究報告書 No.137 / No.117	障害者の就業状況・精神障害者の職場定着に関する調査

必読は厚生労働科学研究の「就労系障害福祉サービス事業所におけるテレワークによる就労の推進のための研究」です。

これは **就労系福祉サービス事業所が在宅就労をどう運営するか** を直接扱った国内研究で、

在宅型 B 型モデルの設計書を書く際の、事実上の教科書になります。

4-6. 職場定着率（出口設計の現実値）

ハローワーク職業紹介経由・精神障害者の職場定着率（NIVR 報告書 No.137）：

時点	通常	職業準備支援受講後
3 か月	53.7%	92.8%
1 年	34.6%	82.7%
3 年	22.4%	50.3%

含意：精神障害者の **1 年定着率は 34.6%（＝約 3 人に 2 人が 1 年以内に離職）**。

一方で **支援を挟むと 3 年時点で約 2 倍の差**がつきます。

→ 「B 型 → 一般就労」を出口 KPI に置のなら、**移行数だけでなく定着数**を見てください。

→ 就労定着支援との連携／自法人での就労定着支援の実施を、中期の検討項目に入れる価値があります。

5. 自分で取りに行くべき「一次データ」と取得先

学術データは揃いましたが、**事業判断を決めるのは自法人と地域の実数**です。取得先を明示します。

5-1. 地域データ（モデル地域比較表を作るため）

ほしいデータ	取得先
地域の B 型事業所数・定員・所在地・サービス内容	WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム （全国の指定事業所を地図・名称・所在地・事業所番号で検索可）
事業所数・従事者数の公式統計	e-Stat「社会福祉施設等調査」
障害者数・手帳所持者数・サービス見込量	市町村の「障害福祉計画（第 7 期）」（自治体 HP で公開。ここに“将来必要量”が書いてある＝1-1 の「サービス不足地域」の根拠にもなる）
ひきこもり支援の実施体制	厚労省「ひきこもり支援に関する取組」ページ、各自治体のひきこもり地域支援センター
自治体独自のひきこもり実態調査	埼玉県・三重県・千代田区などが詳細な調査報告書を公開（設問設計の参考にもなる）

裏技的な使い方：市町村の障害福祉計画には「見込量に対する現在の供給量」が載っています。

これが **1-1 の減算除外特例「サービスが不足している地域」**を主張する際の**一次根拠**になります。

モデル地域候補 3 つについて、まずこれを取ってください。**行政訪問より前にできる作業**です。

5-2. 自法人データ（最優先／誰も代わりに取れない）

1. **RASIEL・INNOVEL** 入居者の日中活動先内訳（3-3 の全国値と比較 → 初期利用者数を推計）
2. **法人内業務棚卸し**（業務名／月間工数／件数／難易度／在宅可否／個人情報有無／現在の外注費）
3. **既存 B 型があれば**：定員・延べ利用日・稼働率・平均工賃月額・生産活動収入／経費・報酬区分・加算取得・人件費・損益

この 2 番目「法人内業務棚卸し」が、本モデルの成否を決める唯一最大の変数です。2 章で見たとおり、B 型の失敗要因は「仕事がない／工賃が出せない」に集約されます。学術データをいくら積んでも、この実数がなければ収支は作れません。

5-3. 押さえるべき制度原典

資料	入手先
令和 8 年度報酬改定（臨時応急的な見直し）の告示・通知	厚労省サイト
就労選択支援 実施マニュアル／Q&A	厚労省 就労選択支援ページ (mhlw.go.jp/stf/newpage_63798.html)
就労系サービスの在宅利用に関する Q&A（令和 6 年 4 月 8 日改訂版）	各自治体が転載（神戸市版等）
令和 8 年 4 月 13 日付 在宅支援の要件遵守徹底の事務連絡	厚労省／自治体経由
令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査 報告書	mhlw.go.jp/content/12200000/001475550.pdf
就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究（令和 6 年 3 月・FVP）	mhlw.go.jp/content/12200000/001248340.pdf ← 生産活動設計の実務書として非常に有用
令和 4 年度 就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握調査	mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html
ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン	mhlw.go.jp （平成 22 年版）
ひきこもり支援ハンドブック ～寄り添うための羅針盤～	厚労省／群馬県等が公開

6. データから導かれる結論（私の判断）

集めたデータを踏まえた、率直な結論です。

結論 1：構想①（GH 連携型）を先に、は データで裏づけられる

- GH 入居者の **41.1%**が既に就労系サービス利用中（3-3）→ 初期利用者を確保できる見込みが立つ
- B 型の失敗要因は「仕事がない」（2 章）→ GH 清掃・修繕は**確実に毎月発生する仕事**
- 立ち上がりが速く、検証サイクルが回る

結論 2：構想②（ひきこもり・在宅型）は「市場は大きい、入口が最難関」

- 市場：146 万人 = 50 人に 1 人（3-1）——十分に大きい
 - しかし 相談したくない層が約 2 割、理由は「解決しないと思う」**51.5%**
- 広報では届かない。家族経由・医療経由の間接ルートしかない（4-4）
- 在宅利用は市町村の個別判断に依存し、**2026 年に要件遵守徹底の通知が出ている**（1-4）

→ 制度リスクが上がっている領域

- ・ **結論**：構想②は「設計フェーズに留める」という資料①の判断が、データの的にも正しい。

ただし設計内容は変えるべきで、「在宅就労事業」ではなく「家族支援を入口とした発掘事業」として設計すべきです。

結論 3：既存資料に足りていなかった、最も重要な追加論点

「新規指定 = 984/1000」（1-1）は、事業構造の根本に関わります。

これは単なる 1.6%減ではなく、「新規に作るより、既存指定を活かす方が有利」というインセンティブが制度側に組み込まれたことを意味します。したがって代表への提案では、

- ・ 新規 B 型を作る前に「既存事業所の多機能型化」「既存指定の活用」が可能か
- ・ モデル地域を「サービス不足地域の特例」に該当し得る自治体から選べないか

の 2 点を検討したうえで、「それでも新規指定で行く」という結論にする必要があります。

この検討をしていない事業計画は、代表・行政の双方から必ず突かれます。

結論 4：説明の際に、正直に線を引くべきこと

IPS のメタ分析では、**QOL・症状・機能**への効果は有意ではありません（4-1）。

「就労支援をすれば利用者が良くなる」という説明は、エビデンスを超えています。

一方で「働けない状態の長期化は心理的苦痛を引き起こす」には因果的証拠があります（4-2）。

提案の言葉は、「働けば良くなる」ではなく「働けない状態を長期化させない」にしてください。

これが、データに対して誠実で、かつ最も強い訴求になります。

7. 出典一覧

制度・報酬

- ・ 令和 8 年度報酬改定解説：<https://aimari-office.com/contents/2026-houshu-kaitei/> / <https://snabi-biz.jp/articles/134> / <https://www.hugmate.net/index/v/594>
- ・ 在宅支援要件：<https://snabi-biz.jp/articles/143> / 神戸市「就労系サービスの在宅利用に関する Q&A（令和 6 年 4 月 8 日改訂版）」
<https://www.city.kobe.lg.jp/documents/45771/20240408zaitakyuriyouqa.pdf>
- ・ 就労選択支援：厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63798.html / 福岡市
<https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/health/syougaijiritusienhou/r071001.html>
- ・ 令和 6 年度報酬改定検証調査：<https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001475550.pdf>
- ・ 生産活動の活性化に関する調査研究（R6.3 FVP）：<https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248340.pdf>

実態統計

- 工賃実績（千葉県まとめ）：<https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/service/shuurou/kouchin/index.html>
- 障害者の就労支援について（厚労省 障害者部会）：
<https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000797543.pdf>
- 就労人数調査 令和 5 年度実績（大阪府）：
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91764/06_shuroninzu.pdf
- 令和 7 年版障害者白書 参考資料：
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r07hakusho/zenbun/siryo_01.html
- 令和 5 年患者調査（e-Stat）：<https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004026052>
- 全国グループホーム実態調査（令和 3 年度）：<http://www.aigo.or.jp/choken/pdf/r3gh1chosa.pdf>
- グループホームの運営及び支援内容等の実態把握調査（R4.3 PwC）：<https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000963526.pdf>
- 就労系障害福祉サービス利用者の支援ニーズ等の実態把握調査（R4 年度）：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html
- WAM NET 障害福祉サービス事業所検索：
<https://www.wam.go.jp/sfkohyooout/COP000100E0000.do>

ひきこもり

- こども・若者の意識と生活に関する調査（令和 4 年度／こども家庭庁）：<https://www.cfa.go.jp/resources/research/chilren-attitudes>
- ひきこもり支援に関する取組（厚労省）：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hikikomori/index.html
- ひきこもり支援施策について（R6 年度 全国こども政策主管課長会議）：
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b1ba8054-23a8-4ad2-94bb-d0f6e0a03c51/887758db/20250314-councils-kodomoseisaku-syukankacho-b1ba8054-3800.pdf
- ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン：<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000147789.pdf>
- 中高年ひきこもり者とその家族への効果的な支援に関する研究（H29）：https://inclkanagawa.net/wp-content/uploads/2017/08/h28_社会福祉推進事業報告書.pdf
- KHJ 全国ひきこもり家族会連合会：<https://www.khj-h.com/>

学術論文

- Modini M, et al. Supported employment: Meta-analysis and review of RCTs of individual placement and support. PLOS ONE 2019. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0212208> / <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30785954/>
- Who benefits from individual placement and support? A meta-analysis. Epidemiol Psychiatr Sci. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35815640/>
- A Systematic Review and Meta-analysis of IPS Supported Employment for Young Adults with Mental Health Conditions. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10221953/>

- Paul KI, Moser K. Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. J Vocat Behav 2009;74:264-282.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879109000037>
- Zhang et al. Epidemiology of Hikikomori: A systematic review and meta-analysis of 19 studies. Psychiatry Clin Neurosci 2025.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pcn.13768> /
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40016086/>
- Koyama A, et al. Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and demographic correlates of "hikikomori" in a community population in Japan.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20074814/>
- Amendola S. Clarifying the position of hikikomori in mental health. 2024.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/18344909241274808>
- 3-day intervention program for family members of hikikomori sufferers: A pilot RCT. Front Psychiatry 2022.
<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2022.1029653/full>
- 精神障害者の援助付き雇用および個別職業紹介とサポートに関する効果についての長期的な追跡研究のシステマティック・レビュー（社会福祉学）：https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssw/54/1/54_KJ00008722544/_article/-char/ja/
- NCNP IPS/日本版個別型援助付き雇用フィデリティ調査：
<https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/research/05.html>
- NIVR 調査研究報告書 No.171 「テレワークに関する障害者のニーズ等実態調査」：
<https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku171.html>
- NIVR 調査研究報告書 No.137 「障害者の就業状況等に関する調査研究」：
<https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku137.html>
- NIVR 調査研究報告書 No.117 「精神障害者の職場定着及び支援の状況に関する研究」：
<https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku117.html>
- 厚生労働科学研究「就労系障害福祉サービス事業所におけるテレワークによる就労の推進のための研究」：<https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/158058>
- 就労継続支援 B 型事業所における利用者工賃と事業所経営に関する考察（兵庫県立大）：<https://www.u-hyogo.ac.jp/mba/pdf/SBR/9-3/001.pdf>

本資料は 2026 年 8 月時点の公開情報の調査に基づく整理です。数値は原典での確認を前提としてください。